

FÁRMACOS INTRAVENOSOS EN URGENCIAS

Julio Tito Camino Acha.

FÁRMACOS	DOSIS - PREPARACIÓN	INDICACIONES - OBSERVACIONES
ACETILSALICILATO DE LISINA (Inyesprin)	1-2 ampollas cada 6 - 8 horas en 100ml SSFF 0,9% en 30 minutos.	1 ampolla equivale a 500mg de aspirina. Disminuir dosis en IC. IH.IR.
ACETILCISTEÍNA ANTIDOTO Ampolla 2g/10ml	dosis inicial: 150mg/kg en 250ml de SG 5% a pasar en 15 minutos, luego 50mg/kg en 500ml de SG 5% a pasar en 4 horas y luego seguido de 100mg/kg en 1000ml de SG 5% a pasar en 15 horas. Contraindicado en insuficiencia renal.	Intoxicación por paracetamol (eficacia antes de las 12h). Intoxicación por tetracloruro de carbono.
ACIDO VALPROICO (Depakine)	NO TOMA PREVIAMENTE: Dosis inicial: 10-15mg/kg. 1-2 amp (400-800mg) IV en 3-5 minutos sin diluir. Después de 30min. Perfusión continua: 1mg/kg/hora hasta máximo de 25mg/kg/día. Para 70kg. Dilusión: 4 ampollas en 500ml SSFF a 21ml/h. SI TOMA PREVIAMENTE: Perfusión continua, misma dosis. Pauta oral: 0,5- 1mg/kg/h.	
ADENOSINA (Adenocor) 1 ampolla 6mg/2ml.	Dosis en bolo IV. 1ª dosis: 6mg IV. Esperar 2 minutos luego 2ª dosis. 2ª dosis: 12mg IV. Esperar 2 minutos luego 2ª dosis. 3ª dosis: 12mg IV.	Administrar en bolo directo en 1 - 2 segundos, lavar con 10ml SSFF 0,9% y levantar miembro superior por donde se administra el medicamento. Siempre el paciente deberá de tener monitor con palas y tira de ECG registrando. Informar al paciente efectos que pueda sentir: Rubor facial, mareos, cefalea, dolor toracico, disnea, arritmias, BAV, dradicardia severa.
ADRENALINA/ EPINEFRINA. (Adrenalina) 1 amp (1mg/ 1ml) Sol 1:10.000	º RCP: 1 amp (1mg/1ml) IV en bolo directo cada 3-5 minutos. Si vía IV no es posible administrar 2-3 amp en 10ml SSFF por tubo endotraqueal. º SHOCK ANAFILACTICO: - SC o IM (sol. 1:1000): 0.3 - 0.5 ml repetir cada 20 minutos hasta 3 dosis - IV. (sol. 1:10.000): 3 - 5ml repetir cada 10 minutos hasta un máximo de 3 dosis. º SOPORTE INOTROPICO: Paciente de 70kg: 21 - 210 ml / h (0,1-1 ugr /kg /min.) º BRADICARDIA: 70 Kg : 6- 31 ml/h (0,03 - 0,151 ugr/kg/min) PERFUSIÓN: 5 amp en 250ml de SF o SG5% (1 ml: 20 ugr) (1 u/min: 3ml/h).	INDICACIONES: RCP. Shock anafilactico. Broncoespasmo. Bradicardia. COMENTARIOS: Potente agonista alfa y beta adrenérgico. PRECAUCIONES: Riesgo de HTA y arritmias. Atraviesa la placenta. No mezclar con bicarbonato, lidocaina, nitratos ni aminofilina.

FÁRMACOS	DOSIS - PREPARACIÓN	INDICACIONES - OBSERVACIONES
AMIODARONA (trangorex) 1 amp 150mg/3ml	DOSIS INICIAL. IV: 5mg/ kg (2 ampollas) en 100ml SG 5% en 30 minutos. Se puede repetir la misma dosis a la hora. DOSIS DE PERFUSIÓN. Paciente 70kg: 24 ml/h de la dilución (10 - 20mg/kg/24h). Dosis máxima 1,2 gr - 2,2 gr / 24h. FV-TVSP. 300mg en 100 ml SG 5% en 10 - 15 minutos. Si no revierte o persiste dar dosis adicional de 150mg en 15 minutos. Luego perfusión de 4 amp (600mg) en 500ml SG a 21ml/h.	COMENTARIO. Incompatible con SSFF. No mezclar. Usar solo cristal. Control ECG y TA.
ATROPINA 1 amp 1mg/1 ml 1 amp 0,5mg/ 1ml	BRADICARDIA:0,5 -1mg IV. directo. Repetible cada 3 - 5 minutos hasta dosis máxima de 3mg. ASISTOLIA: 1mg cada 5min o dosis unica de 3mg IV directo. INTOXICACIÓN POR ÓRGANO FOSFORADO: 0,5 - 2mg en bolo y luego 1 mg cada 5 -10 min hasta que desaparezca la clínica o aparezca signos de atropinización (FC > 120 ó midriasis) PREMEDICACIÓN EN IOT: 0,5mg IV (5 min antes de la IOT)	
ATENOLOL (tenormin) 1 amp 5mg / 10ml.	DOSIS IV DIRECTA: La dosis inicial recomendada es 2,5 mg (5 ml) por vía i.v. en un período de 2,5 minutos (esto es, 1 mg/minuto). Puede repetirse a intervalos de 5 minutos hasta obtener la respuesta deseada o se alcance la dosis máxima de 10 mg. EN INFUSIÓN IV: se administrará a razón de 0,15 mg/kg de peso, durante un período de 20 minutos. La inyección o la infusión puede repetirse, si es preciso, cada 12 horas.	DOSIS MÁXIMA: 10 mg. PRECAUCIÓN: reducir dosis al 50% en asmáticos y pacientes con aclaramiento de creatinina < a 35 ml / min.
ATRACURIO (Tracrium)	DOSIS EN BOLO IV: Paciente de 70kg: 3,5 ml IV en 1 min. (0,5mg/kg) PERFUSIÓN: 0,3 - 0,6 mg/kg/h. DILUCIÓN: 5 amp en 100ml a 16 ml/h.	INICIO: 2- 3 min. DURACIÓN: 60 - 70 min. COMENTARIO: guardar en nevera. EFECTOS SECUNDARIOS: Taquicardia, bradicardia, broncoespas,o, urticaria, hipotensión. ANTÍDOTO: Atropina 1 mg + Neostigmina 1 - 3 mg.